

Gastrostomia Endoscópica (PEG)

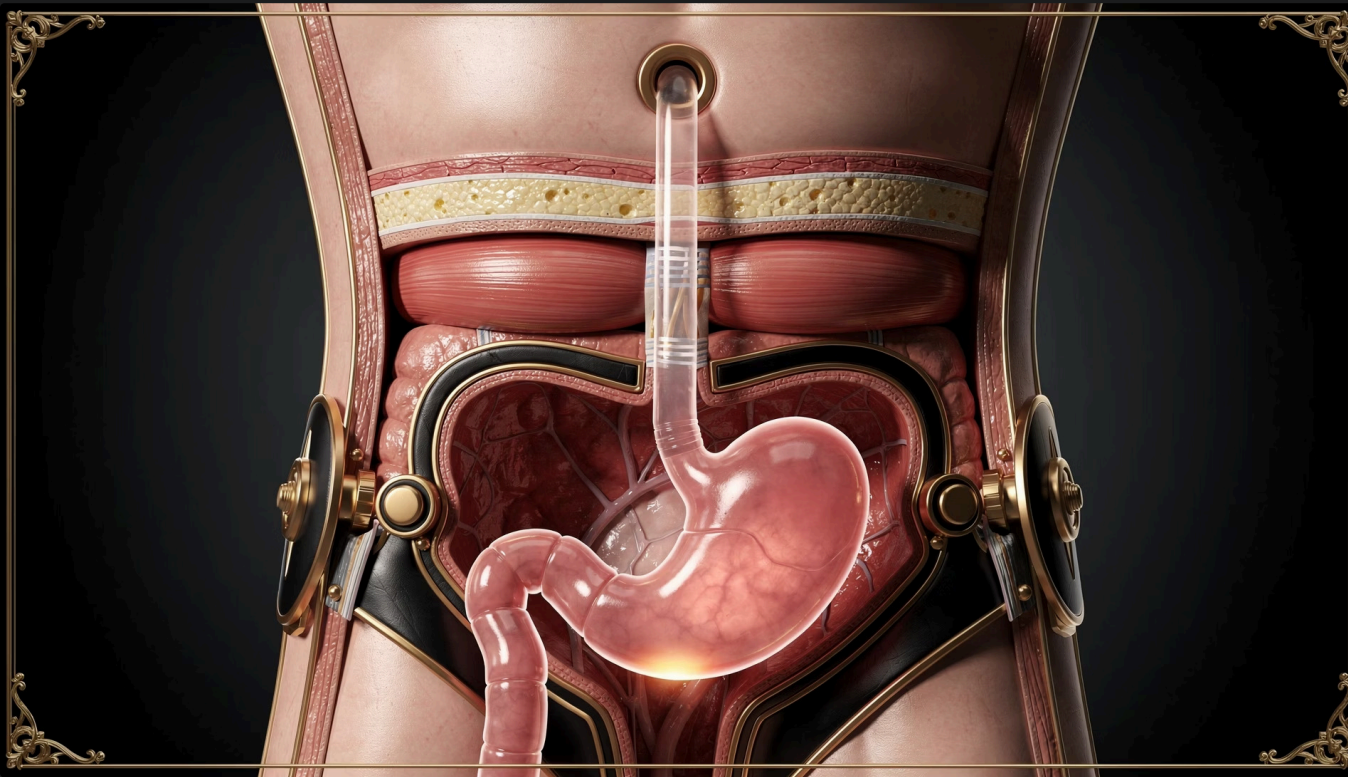
Acesso direto ao estômago através da parede abdominal para suporte nutricional prolongado — uma solução eficaz e minimamente invasiva para pacientes que não conseguem se alimentar por via oral.

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

GASTROENTEROLOGIA



O Que é a PEG?



A **gastrostomia endoscópica percutânea (PEG)** consiste na inserção de uma sonda diretamente no estômago, guiada por endoscopia, sem necessidade de cirurgia aberta.

Percutânea

Acesso pela pele da parede abdominal

Endoscópica

Guiada por endoscópio sob visão direta

Segura

Menor morbidade que técnicas cirúrgicas

Indicação Principal

A PEG é indicada quando o paciente necessita de **nutrição enteral por mais de 30 dias** e apresenta trato gastrointestinal funcionando, mas incapacidade de ingesta oral adequada.

Critério Temporal

Necessidade nutricional
estimada superior a 30 dias

TGI Funcionante

Peristaltismo e absorção
intestinal preservados

Via Oral Inviável

Disfagia grave, rebaixamento de consciência ou obstrução
oral/faríngea



Indicações Clínicas

Doenças Neurológicas

As doenças neurológicas representam a principal causa de indicação de PEG, pela disfagia progressiva e incapacidade de deglutição segura e eficiente.



AVC

Disfagia neurogênica pós-evento isquêmico ou hemorrágico

Parkinson e ELA

Doenças degenerativas com comprometimento progressivo da deglutição

Paralisia Cerebral

Disfunção motora orofaríngea de base, especialmente formas graves

Indicações Clínicas

Outras Indicações



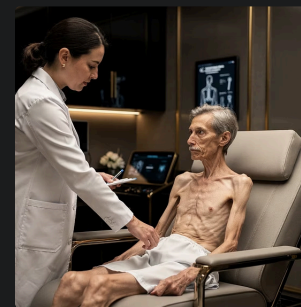
Câncer de Cabeça e Pescoço

Obstrução mecânica tumoral e mucosites por radioterapia impedem alimentação oral



Doenças Crônicas

Insuficiência cardíaca, DPOC avançado e doenças inflamatórias com hipercatabolismo



Má Absorção e Catabolismo

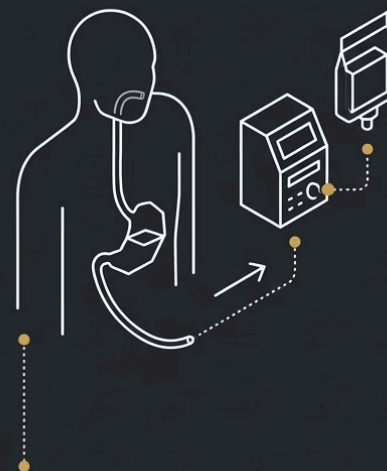
Síndrome do intestino curto, fístulas, estados catabólicos graves com desnutrição

Indicação Adicional

Descompressão Gástrica

Além do suporte nutricional, a gastrostomia pode ser utilizada como **via de descompressão** em situações de obstrução ou hipomotilidade graves.

- **Obstrução intestinal** — neoplásica ou mecânica, com indicação paliativa
- **Íleo paralítico** — estados pós-operatórios prolongados ou disfunção autonômica
- **Gastroparesia grave** — resistente ao tratamento clínico convencional



Nutriiicional

Nutrição Enteral
Ingestão Calórica
Hidratação



Descompressão

Obstrução Intestinal
Íleo Paralítico
Gastroparesia

Segurança do Procedimento

Contraindicações Absolutas

Condições em que o procedimento **não deve ser realizado** sob nenhuma circunstância, dado o risco inaceitável ou a ausência de benefício clínico.



Recusa do Paciente

Princípio da autonomia e consentimento informado



Obstrução Total do TGI

Impossibilidade de passagem do endoscópio ou da sonda



Coagulopatia Não Corrigível

Risco hemorrágico proibitivo sem possibilidade de correção



Isquemia Intestinal

Sofrimento da parede gástrica inviabiliza cicatrização do estoma

Contraindicações Relativas

Condições que **aumentam o risco** do procedimento mas não o inviabilizam absolutamente — exigem avaliação individualizada e, quando possível, correção prévia.



Ascite Volumosa

Risco de peritonite e vazamento peritoneal; drenar previamente se possível

Peritonite Ativa

Infecção intraperitoneal aumenta risco de complicações sépticas

Cirurgias Prévias

Aderências e distorção anatômica dificultam transiluminação e acesso seguro

Infecções Locais

Celulite ou infecção da parede abdominal no sítio de punção

Classificação

Tipos de Gastrostomia



Endoscópica (PEG)

Padrão-ouro — minimamente invasiva, sem incisão cirúrgica



Cirúrgica

Indicada quando PEG não é viável — maior morbidade



Radiológica

Guiada por fluoroscopia — alternativa à endoscopia



Laparoscópica

Menos invasiva que a aberta — visão direta da cavidade

PEG — O Padrão-Ouro

A gastrostomia endoscópica percutânea combina **segurança, eficácia e baixa morbidade**, sendo a técnica de escolha na grande maioria dos casos.

Minimamente Invasiva

Sem incisão cirúrgica ampla — apenas punção guiada

Sedação Leve

Realizada com sedação consciente ou anestesia geral leve

Recuperação Rápida

Retorno precoce à nutrição enteral — em geral em 24h





Técnica Alternativa

Gastrostomia Cirúrgica

Realizada em centro cirúrgico com anestesia geral. Indicada quando a PEG não é tecnicamente possível ou segura.

- Obstrução orofaríngea ou esofágica intransponível ao endoscópio
- Impossibilidade de transiluminação adequada da parede abdominal
- Necessidade de outra intervenção cirúrgica simultânea
- Maior morbidade — reservada a casos selecionados

Técnica Alternativa

Gastrostomia Radiológica

Guiada por fluoroscopia ou tomografia computadorizada, sem necessidade de endoscopia. Indicada quando o acesso endoscópico é inviável.

- Tumores obstrutivos de orofaringe e esôfago
- Anatomia distorcida por cirurgias prévias
- Pacientes com risco elevado à sedação
- Eficácia comparável à PEG em centros especializados





Técnica Alternativa

Gastrostomia Laparoscópica

Abordagem minimamente invasiva com **visão direta da cavidade abdominal**, combinando os benefícios da cirurgia videolaparoscópica com o acesso gástrico direto.

Vantagens

Menor risco de lesão de órgãos adjacentes; recuperação mais rápida que cirurgia aberta

Indicações Específicas

Aderências extensas, obesidade mórbida, anatomia desfavorável à PEG convencional

Preparo Clínico

Avaliação Pré-Operatória

A avaliação criteriosa antes do procedimento é fundamental para **reduzir complicações** e garantir a segurança do paciente.



01

Avaliação Clínica Global

Estado nutricional, comorbidades, medicações em uso e expectativa de vida

03

Risco de Sangramento

Histórico de coagulopatia, uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários

02

Avaliação Cardiorrespiratória

Capacidade de tolerar sedação e decúbito — ECG e espirometria se indicados

04

Risco Infeccioso

Identificação de focos de infecção ativa que contraindicam o procedimento

Exames Laboratoriais Necessários



Hemograma Completo

Avaliação de anemia, plaquetopenia e sinais de infecção sistêmica



Coagulograma

TP, TTPA e INR — fundamentais para segurança hemostática do procedimento



Função Renal e Hepática

Ureia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas — impactam metabolismo e cicatrização



Preparo Imediato

Preparo do Paciente

Jejum de 8 Horas

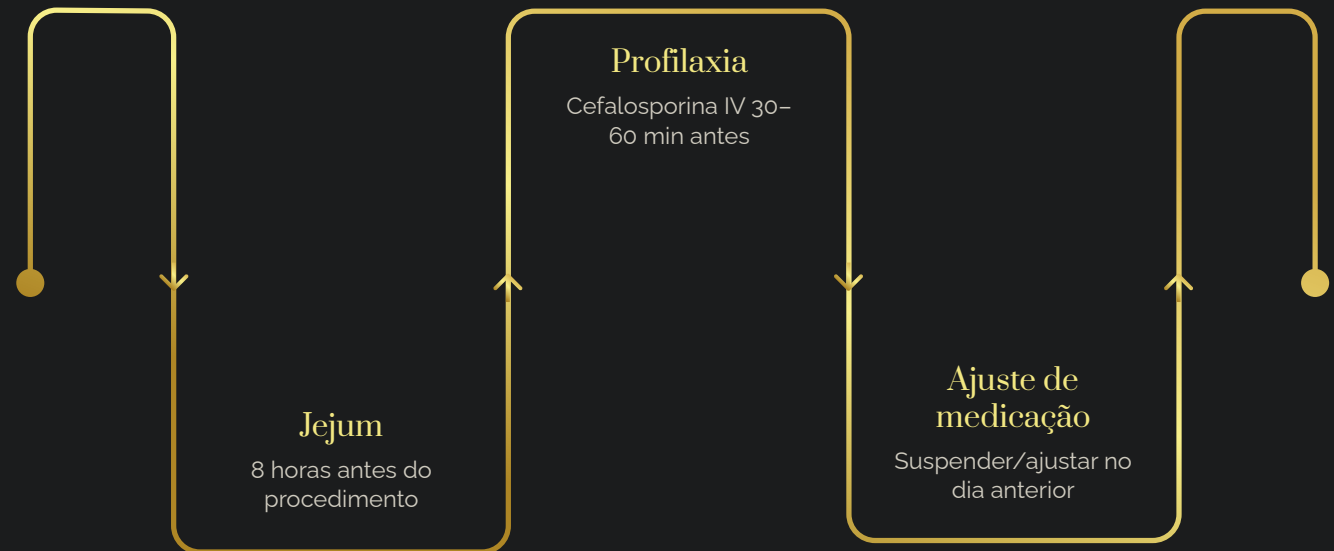
Estômago vazio reduz risco de broncoaspiração durante sedação

Profilaxia Antibiótica

Cefalosporina de 1ª geração IV 30–60 min antes — reduz infecção de sítio

Ajuste de Medicações

Suspensão de insulina, hipoglicemiantes orais e medicações entéricas



Atenção Especial

Manejo de Anticoagulantes

O manejo perioperatório de anticoagulantes e antiagregantes exige **decisão individualizada**, equilibrando risco hemorrágico e tromboembólico do paciente.

Risco de Sangramento

- Suspendar warfarina 5 dias antes (alvo INR < 1,5)
- DOACs: suspender 24–48h conforme função renal
- AAS: avaliar risco-benefício individualmente

Risco Tromboembólico

- FA com alto risco de AVC — considerar heparina ponte
- Próteses valvares mecânicas — não suspender sem orientação cardiológica
- TEP/TVP recente — adiar procedimento se possível



Complicações Precoces

Ocorrem nas primeiras **72 horas** após o procedimento. A maioria é evitável com técnica adequada e profilaxia antibiótica.



Infecção do Sítio

Celulite e fasciíte periestoma — principal complicação (até 30% sem profilaxia)



Sangramento

Lesão de vasos da parede abdominal ou mucosa gástrica durante punção



Peritonite

Extravasamento de conteúdo gástrico — emergência cirúrgica



Pneumoperitônio

Ar livre intraperitoneal — geralmente benigno e autolimitado após PEG

Seguimento Clínico

Complicações Tardias

Surgem após as primeiras semanas a meses do procedimento. Exigem vigilância ativa durante as consultas de acompanhamento.



→ Granuloma Periestoma

Hipergranulação ao redor do estoma — tratado com nitrato de prata ou corticoide tópico

→ Deslocamento da Sonda

Extrusão ou migração — reposicionamento ou nova gastrostomia

→ Obstrução da Sonda

Precipitação de medicamentos ou fórmula — prevenir com lavagem regular com água

→ Síndrome Buried Bumper

Retentor interno migra para dentro da parede gástrica — exige extração endoscópica ou cirúrgica

Conclusão

A gastrostomia endoscópica é um procedimento **seguro, eficaz e fundamental** no suporte nutricional prolongado — desde que indicado corretamente e manejado por equipe treinada.

Procedimento Seguro

Baixa mortalidade e morbidade quando bem indicado



Suporte Nutricional

Garante aporte calórico e hídrico em pacientes vulneráveis

Atuação Multidisciplinar

Médico, nutricionista, enfermagem e fonoaudiologia para melhores resultados

